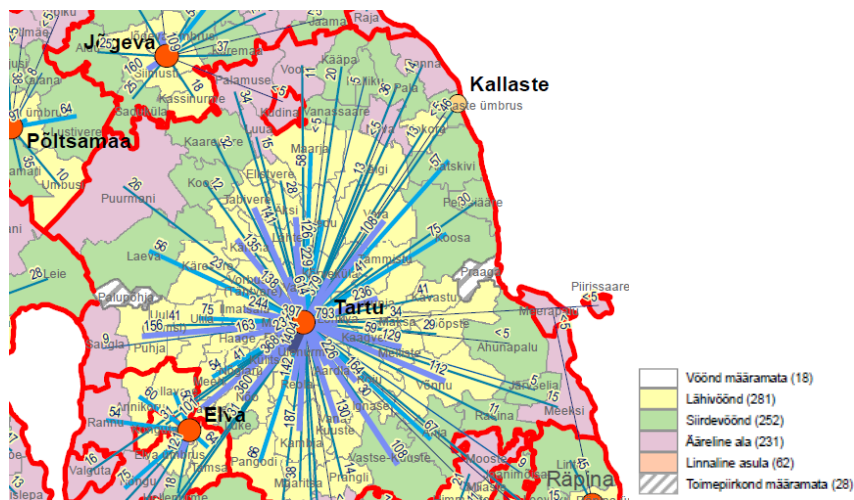


Ekspertarvamus Luunja valla haldusterritoriaalse korralduse võimaliku muutmise kohta

Luunja vald ei täida haldusreformi seadusega pandud miinimumsuurusekriteeriumi 5000 elanikku, seisuga 01.01.2017 oli Luunja vallas registreeritud 4251 elanikku.

Luunja vald kuulub Statistikaameti analüüsi¹ põhjal Tartu linna lähivööndisse (joonis 1).



Joonis 1. Tartu toimepiirkond. Allikas: Statistikaamet (2014) Toimepiirkondade määramine

Luunja vald kuulub Tartu linnapiirkonna koosseisu ja on paljudes eluvaldkondade toimimises seotud Tartu linnaga. Vallas on 20 küla ja üks alevik. Rahvaarvult suurim on Lohkva küla. Kohalikeks tõmbekeskusteks küladele on Lohkva, Luunja ja Kavastu, mis on endisaegsete ühismajandite keskused. Intensiivne ehitustegevus on valda toonud hulgaliselt uusi elanikke, rahvastikuregistri andmetel on elanike arv aastatel 2007-2015 kasvanud enam kui 1000 inimese võrra. Luunja valla arengut mõjutab oluliselt Tartu valglinnastumise protsess. Märkimisväärne osa rahvastikust elab Lohkva (1181 elanikku) ja Veibri (577) külates, mis asuvad Tartu linna administratiivpiiril. Linnast kaugemale jäävates külates asustustihedus oluliselt langeb ja tegu on pigem maalise elulaadi viljelemisega.

Luunja valla ühendamisel Vabariigi Valitsuse algatusel tuleb kaaluda ettepaneku esitamisel kahe võimaluse vahel – ühendamine Tartu vallaga või Tartu linnaga. Asjakohane ei ole Luunja valla ühendamine Haaslava, Mäksa ja Võnnu valdade baasil moodustava uue omavalitsusüksusega, mis on märksa maalisema iseloomuga kui Luunja vald ning puudub kogemus ja ressursid Tartu valglinnastumise käigus Tartu linnapiiril kujunenud tiheasustuse piirkondade arendamiseks.

Tartu linnaga ühendamise poolt on järgmised asjaolud:

- Tartu linnaga ühendatakse linnaga kokku kasvanud Lohkva ja Veibri külade tiheasustusalad Luunja vallast viies need ühtse juhtimise alla ja moodustub loogiline planeerimispiirkond. Samas maaliste Luunja valla alade arendamine eeldab keskuslinna käsitlusest erineva linnastu kontseptsiooni rakendamist.

¹ Statistikaamet (2014) Toimepiirkondade määramine.

- Luunja valla Lohkva ja Veibri külates elab ligi pool Luunja valla elanikkonnast, kes saavad ühinemisel Tartu linnaga võimaluse rääkida kaasa arengutes, mis mõjutavad nende tegelikku igapäevast teenuste tarbimist. Olukord, kus elanikud ei saa oma elukeskkonda maksumaksjana mõjutada ja selle arengus kaasa rääkida, ei ole demokraatlik.
- Ühise omavalitsusena on liikumiskeskcond paremini korraldatav, et tagada ennekõike keskuslinnas Tartus töökohtade, teenuste ja vaba aja võimaluste kättesaadavus praeguse Luunja valla elanikele.
- Tekivad paremad võimalused läbi planeerimise arendada Tartu linna. Lohkva ja Veibri küla ühinemisel moodustuks loogiline Tartu linna tervikala.

Tartu vallaga ühendamise poolt on järgmised asjaolud:

- Ühinemisel Tartu vallaga saab Vabariigi Valitsuse algatatud ühendamise käigus pakkuda terviklahendused Tartu valla kujundamiseks (arvestades ka teisi ühinevad omavalitsusi) luues parima elukeskkonna ja lahendused elanikele ühises toimealas.
- Tartu vald ja Luunja vald on arengus sama sotsiaal-majandusliku iseloomuga omavalitsused, neil on analoogsed arenguprobleemid ja väljakutsete lahendamine. Neil on vahetud Tartu valglinnastumise mõjuga piirkonnad, sh sisuliselt Tartu linnaga kokku kasvanud alad ning samas on valdadel ka linnalähedase maapiirkonnana Tartu linna vahetust mõjust väljapoole jäävad lähivööndi alad (kuigi ka nendes piirkondades on Tartu linnal suur mõju võimekusega pakkuda töökohti, avalikke teenuseid ja võimalusi vaba aja veetmiseks).
- Luunja ja Tartu vald on teinud väga olulisi pingutusi, et tugevdada omavalitsuste terviklikkust ja sisemist sidusust. Seega on olulisel kohal olnud mõlemas omavalitsuses nii linnalise kui maalise elulaadi toetamine. Sarnasuse tõttu on juhtimiskultuuride ühendamine lihtsam.
- Luunja vallavolikogu on teinud vabatahtliku ühinemise etapis ettepaneku ühinemiseks Tartu vallaga (kes küll keeldus esitatud ettepanekust).



MassHealth Pediatric Behavioral Health Medication Initiative

BACKGROUND

The Pediatric Behavioral Health Medication Initiative proactively requires prior authorization for pediatric members (generally members less than 18 years of age) for certain behavioral health medication classes and/or specific medication combinations (i.e., polypharmacy) that have limited evidence for safety and efficacy in the pediatric population.

As part of this initiative, the following situations will require a prior authorization:

1. **Behavioral health medication polypharmacy:** (i.e., alpha₂ agonists, antidepressants, antipsychotics, armodafinil, atomoxetine, benzodiazepines, buspirone, cerebral stimulants, donepezil, hypnotic agents, memantine, meprobamate, modafinil, mood stabilizers [agents considered to be used only for seizure diagnoses are not included], naltrexone, prazosin, viloxazine, and xanomeline/trospium) filled within a 45-day period for members less than 18 years of age:

- Pharmacy claims for 4 or more behavioral health medications **if one of the following is included:** an antipsychotic, a benzodiazepine, divalproex/valproate, lithium, or a tricyclic antidepressant
 - Pharmacy claims for 5 or more behavioral health medications (regardless of the medications included)
- 2. Antipsychotic polypharmacy:** overlapping pharmacy claims for two or more antipsychotics for at least 60 days within a 90-day period for members less than 18 years of age;
 - 3. Antidepressant polypharmacy:** overlapping pharmacy claims for two or more antidepressants for at least 60 days within a 90-day period for members less than 18 years of age;
 - 4. Cerebral stimulant polypharmacy:** overlapping pharmacy claims for two or more cerebral stimulants (immediate release and extended release formulations of the same chemical entity are counted as one) for at least 60 days within a 90-day period for members less than 18 years of age;
 - 5. Mood stabilizer polypharmacy:** overlapping pharmacy claims for three or more mood stabilizers (agents considered to be used only for seizure diagnoses are not included) for at least 60 days within a 90-day period for members less than 18 years of age;
 - 6. Benzodiazepine polypharmacy:** overlapping pharmacy claims for two or more benzodiazepines (hypnotic benzodiazepine agents, clobazam, nasal and rectal diazepam, and nasal midazolam are not included) for at least 60 days within a 90-day period for members less than 18 years of age;
 - 7. Antipsychotic** pharmacy claim for members less than ten years of age;
 - 8. Antidepressant, armodafinil, atomoxetine, benzodiazepine, buspirone, donepezil, hypnotic, memantine, meprobamate, modafinil, mood stabilizer (agents considered to be used only for seizure diagnoses are not included), naltrexone, prazosin, viloxazine, or xanomeline/trospium** pharmacy claim for members less than six years of age;
 - 9. Alpha₂ agonist or cerebral stimulant** pharmacy claim for members less than three years of age.

The reference table below lists the behavioral health medications included in the Pediatric Behavioral Health Medication Initiative. Further information on the prior authorization requirements, including approval criteria, can be found within the MassHealth Drug List at www.mass.gov/druglist.

Pediatric Behavioral Health Medication Initiative Medication List ¹					
Antidepressants			Mood Stabilizers		
amitriptyline		levomilnacipran	carbamazepine		oxcarbazepine
amoxapine		mirtazapine	divalproex		pregabalin
bupropion		nefazodone	gabapentin		topiramate
citalopram		nortriptyline	lamotrigine		valproic acid
clomipramine		paroxetine	lithium		
desipramine		phenelzine	Antianxiety Agents		
desvenlafaxine		protriptyline	alprazolam		diazepam ³
dextromethorphan/bupropion		selegiline ²	buspirone		lorazepam
doxepin		sertraline	chlordiazepoxide		meprobamate
duloxetine		tranylecypromine	chlordiazepoxide/ amitriptyline		midazolam ³
escitalopram		trazodone	clonazepam		oxazepam
esketamine		trimipramine	clorazepate		
fluoxetine		venlafaxine	Hypnotics		
fluvoxamine		vilazodone	daridorexant		quazepam
imipramine		vortioxetine	doxepin ⁴		suvorexant
isocarboxazid		zuranolone	eszopiclone		temazepam
Antipsychotics			eszopiclone		triazolam
aripiprazole		olanzapine/fluoxetine	flurazepam		zaleplon
asenapine		olanzapine/samidorphan	lemborexant		zolpidem
brexpiprazole		paliperidone	Alpha ₂ -Agonists		
cariprazine		perphenazine	clonidine		guanfacine
chlorpromazine		perphenazine/amitriptyline	Stimulants		
clozapine		pimozide	amphetamine		lisdexamfetamine
fluphenazine		quetiapine			

Pediatric Behavioral Health Medication Initiative Medication List ⁴			
Antidepressants		Mood Stabilizers	
haloperidol	risperidone	dexmethylphenidate	methamphetamine
iloperidone	thioridazine	dextroamphetamine	methylphenidate
loxapine	thiothixene	dextroamphetamine/ amphetamine	serdexmethylphenidate
lumateperone	trifluoperazine		dexmethylphenidate
lurasidone	xanomeline/trospium	Miscellaneous	
molindone	ziprasidone	armodafinil	modafinil
olanzapine		atomoxetine	naltrexone ⁵
		donepezil	prazosin
		memantine	viloxazine

¹Short-acting intramuscular injectable and intravenous formulations are excluded from the Pediatric Behavioral Health Medication Initiative requirements.

²Emsam (selegiline) is the only selegiline formulation included in the Pediatric Behavioral Health Medication Initiative.

³Nasal and rectal diazepam and nasal midazolam formulations are excluded from the Pediatric Behavioral Health Medication Initiative requirements.

⁴Doxepin tablet is classified as a hypnotic agent and the Pediatric Behavioral Health Medication Initiative requirements for antidepressants do not apply. Pediatric Behavioral Health Medication Initiative requirements for hypnotics apply.

⁵Vivitrol (naltrexone injection) is excluded from the Pediatric Behavioral Health Medication Initiative requirements.